Σε συνεργασία με
την Ουρολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Σύγχρονοι Ουρολογικοί Προβληματισμοί

Χορηγούνται 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΑΘΗΝΑ

Αίγλη Ζαππείου

6 Σεπτεμβρίου
2020

© 2020 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», σας καλωσορίζει και φέτος στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, στην Αίγλη Ζαππείου, με θέμα «Σύγχρονοι Ουρολογικοί προβληματισμοί».

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες πολλά δεδομένα της επιστημονικής μας σκέψης και του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών έχουν τροποποιηθεί από τις αλλαγές που η πανδημία του κορωνοϊού επέβαλε. Παράλληλα, όμως, οι εξελίξεις στο χώρο της Ουρολογίας είναι ταχύτατες και υποχρέωση όλων μας είναι να τις παρακολουθούμε, να τις αναπαράγουμε, αλλά και να τις επικοινωνούμε.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Κλινική μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση ενός άρτιου κι ολοκληρωμένου προγράμματος με στόχο να καλύψει σε βάθος ένα μεγάλο φάσμα Ουρολογικών καλοήθων και κακοήθων παθήσεων και να απαντήσει σε πολλά σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν την Ειδικότητά μας. Αρωγοί στο έργο μας θα είναι διακεκριμένοι Συνάδελφοι ομιλητές, οι οποίοι θα εξαντλήσουν μία ευρεία θεματολογία και θα παρουσιάσουν τις νεότερες προσεγγίσεις σε μια εποχή ιδιαίτερη και απαιτητική.

Με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει στην επιτυχία της ανταλλαγής απόψεων και του γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε στην εκδήλωσή μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Κωνσταντίνος Ντούμας
Συντονιστής Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Γλύκας Ιωάννης
Ντούμας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

Επιστημονική Επιτροπή

Δεληβελιώτης Χαράλαμπος
Μητρόπουλος Διονύσιος
Μπάμιας Αριστοτέλης
Ντούμας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος
Στραβοδήμος Κωσταντίνος
Φασουλάκης Χαράλαμπος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

Επιστημονικό Πρόγραμμα

08:30-09:00	**Προσέλευση Εγγραφές**	
09:00-10:00	**Καρκίνος ουροδόχου κύστης** ***Προεδρείο: Φασουλάκης Χ.***	
09:00-09:10	Μοριακή υποκατηγοριοποίηση ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης. Εφαρμογή στην Κλινική πράξη.	**Στασινόπουλος Κ.**
09:10-09:20	Ο ρόλος της mpMRI (VIRADS) στη διάγνωση και σταδιοποίηση ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης	**Πετρολέκας Α.**
09:20-09:30	Νεότερες θεραπείες σε ασθενείς μετά αποτυχία BCG	**Κοριτσιάδης Γ.**
09:30-09:40	Η θέση της ρομποτικής ριζικής κυστεκτομής. Σύγκριση με την ανοιχτή	**Γαλανάκης Ι.**
09:40-09:50	pT0 σε παρασκεύασμα ριζικής κυστεκτομής: «Κακώς έβγαλα την κύστη μου;»	**Αρίστας Ο.**
09:50-10:00	Συζήτηση	
10:00-11:00	**Καρκίνος νεφρού** ***Προεδρείο: Δεληβελιώτης Χ.***	
10:00-10:12	Διαχείριση μικρών νεφρικών μαζών	**Αβακιάν Ρ.**
10:12-10:24	Τεχνικές νεφρο-συντηρητικών χειρουργείων: Ανοιχτή, λαπαροσκοπική ή ρομποτική; Μερική νεφρεκτομή ή ογκεκτομή;	**Σταθούρος Γ.**
10:24-10:36	Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής στη μεταστατική νόσο	**Παπαδόπουλος Γ.**
10:36-10:48	Νεφρο-συντηρητική χειρουργική σε ουροθηλιακό καρκίνο ανώτερου ουροποιητικού	**Αναστασίου Ι.**
10:48-11:00	Συζήτηση	
11:00-11:30	**Διάλειμμα – Καφές**	
11:30-12:30	**Καρκίνος προστάτη Ι** ***Προεδρείο: Μητρόπουλος Δ.***	
11:30-11:40	Ο ρόλος της mpMRI στην ένταξη και ενεργό παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του προστάτη	**Σεραφετινίδης Ε.**
11:40-11:50	**“**Focal Therapy’’: νεότερα δεδομένα	**Φραγκούλης Χ.**
11:50-12:00	Απεικονιστικές τεχνικές σε βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτομή	**Σπυρόπουλος Ε.**
12:00-12:10	Λεμφαδενεκτομή σε βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτομή: Έχει θέση;	**Σκρεπέτης Κ.**
12:10-12:20	Ριζική θεραπεία σε ολιγομεταστατική νόσο: Τί δεδομένα διαθέτουμε;	**Παπατσώρης Α.**
12:20-12:30	Συζήτηση	

12:30-13:30	**Καρκίνος προστάτη ΙΙ** ***Προεδρείο: Ντούμας Κ.***	
12:30-12:42	Ανοιχτή vs ρομποτική ριζική προστατεκτομή	**Καλληδώνης Π.**
12:42-12:54	Θεραπευτική προσέγγιση υψηλού κινδύνου και τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη	**Στραβοδήμος Κ.**
12:54-13:06	Διαχείριση ορμονο-ευαίσθητου μεταστατικού καρκίνου. Υπάρχει ιδανική θεραπεία;	**Αναγνώστου Θ.**
13:06-13:18	Μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη	**Σκριάπας Κ.**
13:18-13:30	Συζήτηση	
13:30-15:30	**Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα**	
15:30-16:30	**Το βήμα των Ογκολόγων** ***Προεδρείο: Μπάμιας Α.***	
15:30-15:42	Βασικές αρχές Ανοσοθεραπείας	**Λιόντος Μ.**
15:42-15:54	Ο ρόλος της Ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του νεφρού: 1ης γραμμής θεραπεία;	**Κουτσούκος Κ.**
15:54-16:06	Ο ρόλος της Ανοσοθεραπείας στον καρκίνο της κύστης	**Κωστούρος Ε.**
16:06-16:18	Έχει θέση η Χημειοθεραπεία στον ουροθηλιακό καρκίνο του ανώτερου Ουροποιητικού;	**Κωτσαντής Ι.**
16:18-16:30	Συζήτηση	
16:30-17:00	**Το βήμα των Φοιτητών και των Ειδικευομένων** ***Προεδρείο: Ντούμας Κ.***	
16:30-16:45	Καρκίνος ουροδόχου κύστεως σε νέους ασθενείς	**Ντούμας Γ.**
16:45-17:00	Προβληματισμοί στη εκπαίδευση των Ελλήνων Ειδικευομένων στην Ουρολογία	**Γλύκας Ι.**
17:00-18:00	**Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη & Νευροουρολογία** ***Προεδρείο: Μπούγας Δ.***	
17:00-17:10	Συνδυασμοί φαρμάκων στην ΚΥΠ: Η σύγχρονη τάση;	**Καπόγιαννης Φ.**
17:10-17:20	Κατανοώντας τη νυκτουρία: Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση	**Παπαδημητρίου Β.**
17:20-17:30	Ο ρόλος της Ουροδυναμικής πριν την αδενωματεκτομή: Μπορεί να μας βοηθήσει στην αποφυγή λανθασμένων ενδείξεων;	**Μητσογιάννης Η.**
17:30-17:40	Διαχείριση ΚΥΠ σε ασθενείς με χρόνιες Νευρολογικές παθήσεις	**Φλωράτος Δ.**
17:40-17:50	Πρακτικά προβλήματα στη διενέργεια αυτοκαθετηριασμών	**Ραπίδη Α.**
17:50-18:00	Συζήτηση	
18:00-18:30	**Διάλειμμα – Καφές**	

18:30-20:00	**Στυτική Δυσλειτουργία/Υπογονιμότητα, Λοιμώξεις, Λιθίαση** ***Προεδρείο: Φραγκούλης Α.***	
18:30-18:40	Αντιμετώπιση Στυτικής Δυσλειτουργίας μετά ριζική προστατεκτομή	**Αδαμάκης Ι.**
18:40-18:50	Όψιμος Υπογοναδισμός (LOH): Πόσο συχνά αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται;	**Πρωτογέρου Β.**
18:50-19:00	Κιρσοκήλη: Τελικά, πότε χειρουργείται;	**Μακαρούνης Κ.**
19:00-19:10	Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις στις γυναίκες	**Πορφύρης Ο.**
19:10-19:20	Ουροσήψη: Παράγοντες κινδύνου στην αντιμετώπιση. Είναι πάντα αναστρέψιμη;	**Αρμένης Κ.**
19:20-19:30	Διάμεση κυστίτιδα: Νόσος «φάντασμα»;	**Νικολόπουλος Π.**
19:30-19:40	Λίθος πυέλου 2-3 cm: Ποια η καλύτερη αντιμετώπιση;	**Φραγκιάδης Ε.**
19:40-19:50	Ασυμπτωματική λιθίαση: Πότε χρειάζεται παρέμβαση;	**Μπερδεμπές Μ.**
19:50-20:00	Συζήτηση - Κλείσιμο	

Κατάλογος ομιλητών

Αβακιάν Ραφφή	MD, FEBU, Επιμελητής Α' Ουρολογίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
Αδαμάκης Ιωάννης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ
Αναγνώστου Θεόδωρος	PhD, FEBU, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγιος Σάββας»
Αναστασίου Ιωάννης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρίστας Οδυσσέας	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Αρμένης Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Γαλανάκης Ιωάννης	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Αν. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γλύκας Ιωάννης	Ουρολόγος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος	Καθηγητής Ουρολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Καλληδώνης Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Ενδοσκοπικής και Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καπόγιαννης Φίλιππος	Επικουρικός Επιμελητής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κοριτσιάδης Γεώργιος	Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Κωστούρος Ευθύμιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Κωτσαντής Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λιόντος Μιχάλης	Παθολόγος- Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Ογκολογική Μονάδα Θεραπευτικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μακαρούνης Κωνσταντίνος	MD, FEBU, FECSM, cPhD, Ουρολόγος Ανδρολόγος
Μητρόπουλος Διονύσιος	Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ
Μητσογιάννης Ηρακλής	Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Μπάμιας Αριστοτέλης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Παθολογίας-Ογκολογίας, Διευθυντής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μπερδεμπές Μαρίνος	Επικουρικός Επιμελητής, Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Μπούγας Δημήτριος	Διευθυντής Ουρολογίας, Υπεύθυνος Ουροδυναμικού Τμήματος, Α΄ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Νικολόπουλος Παναγιώτης	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, 417 ΝΙΜΤΣ
Ντούμας Γεώργιος	Φοιτητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Ντούμας Κωνσταντίνος	FEBU, Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παπαδημητρίου Βάιος	Χειρουργός Ουρολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο, Λαμία
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Παπατσώρης Αθανάσιος	Αν. Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Πετρολέκας Ανδρέας	MD, FEBU, Αναπλ. Διευθυντής, Β' Ουρολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Πορφύρης Ορέστης	Επιμελητής Α' Ουρολογίας, Προϊστάμενος Ουρολογικού Τμήματος, Γ. Ν. Λακωνίας, Ν. Σπάρτης
Πρωτογέρου Βασίλειος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής Ε' Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, Επιστημονικός Διευθυντής Androclinic
Ραπίδη Αναστασία-Χριστίνα	Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Σεραφετινίδης Εφραίμ	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
Σκρεπέτης Κωνσταντίνος	Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Μεσσηνίας
Σκριάπας Κωνσταντίνος	Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Λάρισας
Σπυρόπουλος Ευάγγελος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ. εα., τ. Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής ΝΝΑ
Σταθούρος Γεώργιος	Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Στασινόπουλος Κωνσταντίνος	Ουρολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', Γ.Ν. Σπάρτης
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος	Χειρουργός Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Φασουλάκης Χαράλαμπος	Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φλωράτος Διαμαντής	MD, FEBU, PhD, Ουρολόγος, Υπεύθυνος Ουροδυναμικού Ιατρείου, ΚΑΑ Φιλοκτήτης
Φραγκιάδης Ευάγγελος	Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Φραγκούλης Αριστόδημος	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Φραγκούλης Χαράλαμπος	MD, MSc, Ουρολόγος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

AMGEN Oncology

ariti

astellas

BAUSCH Health

Bayer

DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

EuroTec Ostomy care

FARAN

genepharm

INNOVIS Future health today

inside MEDICAL

IPSEN Innovation for patient care

Lavipharm

Meditrina pharmaceuticals

RAFARM

RECORDATI HELLAS GROUP

SOFMEDICA LIFE SAVING INNOVATION

sti ivi για την υγεία

STORZ KARL STORZ—ENDOSKOPE

BIANEE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Vocate Φαρμακευτική α.ε.

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση
Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

Σε συνεργασία με
την Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Τόπος διεξαγωγής
Αίγλη Ζαππείου
(Αίθουσα Ολυμπία)
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα 105 57
Τηλ.: 210 3369 300

Ημερομηνία διεξαγωγής

6 Σεπτεμβρίου 2020

Εγγραφές - Πιστοποίηση

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη της Ημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Γραμματεία Συνεδρίου

ets Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: ets@otenet.gr • ets@events.gr
Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το το www.events.gr (πολιτική απορρήτου).

Procef®

Κεφπροζίλη

Η επιλογή στην αντιβίωση!



Ούτε μια ώρα χαμένη από τη ζωή σου!

Θεραπευτικές Ενδείξεις

- Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
- Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού
- Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
- Μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις περιλαμβανομένης της οξείας κυστίτιδας



Λ.Τ. 8,45 €

Λ.Τ. 8,32 €

Λ.Τ. 9,23 €

- Καλά Ανεκτό
- Ευχάριστη Γεύση Εναιωρήματος

BAUSCH+ Health

#2 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΣ

Best Workplaces™ Great Place To Work. HELLAS 2020

Improving people's lives through our healthcare products

Για την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος απευθυνθείτε στην εταιρία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα **Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Λ. Πεντέλης 53, 152 35 Βριλήσσια,
Τηλ.: 210 81 08 460, **www.bauschhealth.gr**

PRO-GR-200714



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ:00357 22483858

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide

Το XTANDI™ είναι **εγκεκριμένο** τόσο για τον μη μεταστατικό όσο και για τον μεταστατικό CRPC *[1]

XTA/ADV 1/05.2020



ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ XTANDI™

Το XTANDI™ προσφέρει στους ασθενείς σας αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον CRPC*, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι μεταστάσεων, και είναι γενικά καλά ανεκτό, με καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας.[1-3]

Τώρα ΝΕΑ μορφή - δισκία 40 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 16.17 του παρόντος εντύπου.
Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.
Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 μαλακά καψάκια - 40 mg /CAP): €2.261,67
Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67

CRPC= ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη
Τα προφίλ των ασθενών είναι πλασματικά και ανταποκρίνονται στα κριτήρια ένταξής τους στις μελέτες PROSPER και PREVAIL.

References: 1. XTANDI™ ΠΧΠ. **2.** Hussain M et al. NEJM. 2018; 378: 2465-2474. **3.** Beer TM et al. Eur Urol. 2017; 71: 151-4.

astellas

Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi™ enzalutamide

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xtandi - 40 mg καψάκια, μαλακά.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Xtandi - 40 mg καψάκια, μαλακά.
Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 40 mg enzalutamide.
Έκδοχο με γνωστή δράση.
Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 57,8 mg σορβιτόλης.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Καψάκιο, μαλακό. Λευκά έως υπόλευκα, επιμήκη μαλακά καψάκια (περίπου 20 mm x 9 mm), με τυπωμένο το "ENZ" με μαύρο μελάνι στη μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Xtandi ενδείκνυται για: • τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες. • τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά. • τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντοσεταξέλη.
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.
Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων. Συνεπώς μια ανασκόπηση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορείς πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η συγχορήγηση με βαρφαρίνη και αντιπηκτικά ομοιάζοντα με κουμαρίνη πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR).
Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.
Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής μπορεί επίσης να αυξηθούν.
Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στηθάγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βραδυκαρδία ή ανεξέλεγκτη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.
Η θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT, οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.
Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχορήγηση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντοσεταξέλης. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντοσεταξέλη. Έκδοχα: Το Xtandi περιέχει σορβιτόλη (E420). Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε οίδημα προσώπου, γλώσσας, χείλους ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, κατάγματα, και υπέρταση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν πτώση, νοητική διαταραχή και ουδετεροπενία. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,4% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βικαλουταμίδη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Όχι συχνές: Λευκοπενία, ουδετεροπενία Μη γνωστές¥: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές¥: οίδημα προσώπου, οίδημα γλώσσας, οίδημα χείλους, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές: άγχος Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών Όχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις* Μη γνωστές† : σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES)
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχαιμική καρδιακή νόσος‡ Μη γνωστές†: παράταση του διαστήματος QT
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξάψεις, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές†: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ξηροδερμία, κνησμός Μη γνωστές†: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάγματα# Μη γνωστές†: μυαλγία, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οσφυαλγία
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: γυναικομαστία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάντληση, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Συχνές: πτώση

* Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
¥ Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Σπασμών» συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
† Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Εμφράγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχαιμική καρδιακή νόσο», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στηθάγχη, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στηθάγχη, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας.
‡ Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Επιληπτική κρίση
Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 13 (0,4%) από τους 3179 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ ένας ασθενής (<0,1%) που έλαβε εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βικαλουταμίδη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμάκωσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης.
Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.
Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσδένονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστικότητα των διαύλων των ιόντων χλωρίου του GABA.
Ισχαιμική καρδιακή νόσος
Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχαιμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 2,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 , Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62 , 2333 BE Leiden, Ολλανδία.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/13/846/001
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 23 Οκτωβρίου 2018

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή τιμή
40 mg /CAP	Κουτί x 112 μαλακά καψάκια	€ 2.261,67

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

astellas
Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi™ enzalutamide

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide
Κατάλογος εκδόχων:
Πυρήνας δισκίου: Υπρομελλόζη οξική ηλεκτρική, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κολλοειδές άνυδρο οξείδιο του πυριτίου, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη (8000), τιτανίου διοξείδιο (E171), σιδήρου οξείδιο κίτρινο E172

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Xtandi – 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κίτρινα στρογγυλά – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.
Xtandi – 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κίτρινα σβάλ – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Xtandi ενδείκνυται για:

- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες.
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά.
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντοσεταξέλη.

4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.

Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων. Συνεπώς μια ανασκόπηση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορείς πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η συγχορήγηση με βαρφαρίνη και αντιπηκτικά ομοιάζοντα με κουμαρίνη πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (*International Normalised Ratio*-INR).

Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής μπορεί επίσης να αυξηθούν.

Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στηθάγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (*Left Ventricular Ejection Fraction*-LVEF) ≥ 45%, βραδυκαρδία ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

Η θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT, οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (*Torsade de pointes*) πριν την έναρξη του Xtandi.

Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχορήγηση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντοσεταξέλης, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντοσεταξέλη.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οίδημα προσώπου, γλώσσας, χείλους ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8).

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, κατάγματα, και υπέρταση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν πτώση, νοητική διαταραχή, και ουδετεροπενία. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0, 4% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βικαλουταμίδη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≤1/10), συχνές (≤ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≤ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≤ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Όχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία Μη γνωστές*: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές*: οίδημα προσώπου, οίδημα γλώσσας, οίδημα χείλους, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές: άγχος Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στη προσοχή, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών Όχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις[¥] Μη γνωστές* : σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχαιμική καρδιακή νόσος[‡] Μη γνωστές*: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξάψεις, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές*: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ξηροδερμία, κνησμός Μη γνωστές*: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάγματα[‡] Μη γνωστές*: μυαλγία, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οσφυαλγία
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: γυναικομαστία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάντληση, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Συχνές: πτώση

* Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
¥ Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Σπασμών» συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
† Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Εμφράγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχαιμική καρδιακή νόσο», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στηθάγχη, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στηθάγχη, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας.
‡ Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Επιληπτική κρίση
Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 13 (0,4%) από τους 3179 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ ένας ασθενής (0,1%) που έλαβε εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βικαλουταμίδη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμάκωσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης.
Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.
Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσδένονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστικότητα των διαύλων των ιόντων χλωρίου του GABA.
Ισχαιμική καρδιακή νόσος
Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχαιμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 2,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)
EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

23 Οκτωβρίου 2018

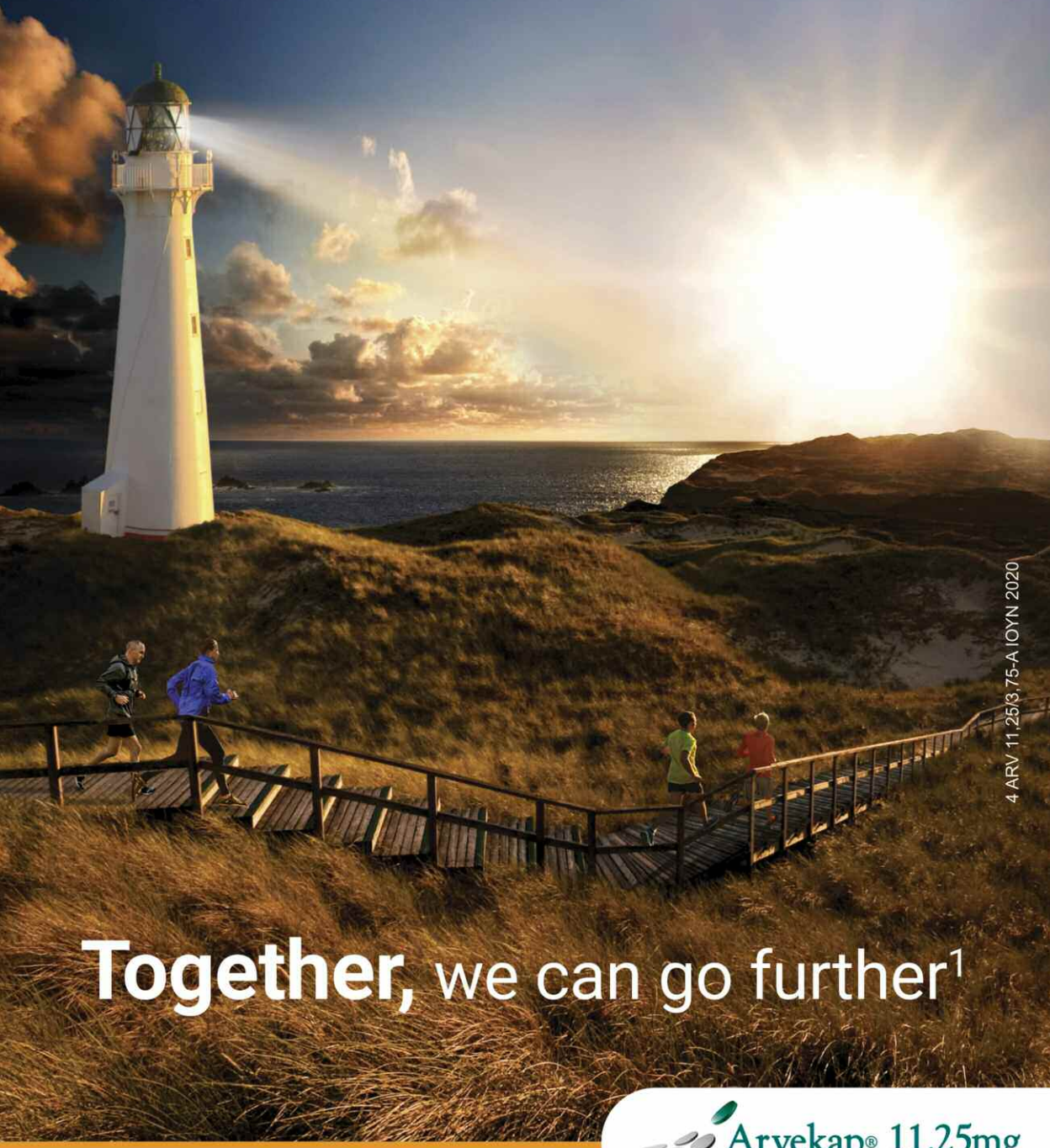
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή τιμή
40 mg /TAB	Κουτί Χ 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 2.261,67

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

astellas
Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr



4 ARV 11,25/3,75-A ΙΟΥΝ 2020

Arvekap® 11,25mg
triptorelin

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN
Innovation for patient care

Δ.Τ.Φ.: 13/12/2019 - Τ.Π.: 153.62€ - Λ.Τ.: 194.73€
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930
1. ARVEKAP® 11,25mg, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος στην σελίδα

IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Arvekap 11,25 mg ®. **1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Arvekap 11,25 mg. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Triptorelin 11,25 mg ανά φιαλίδιο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλέπε παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα (ΕΜ ή ΥΔ). **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις:** - Καρκίνος του προστάτη: Θεραπεία του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, ως μονοθεραπεία ή συγχορηγούμενη και επικουρική στην ακτινοθεραπεία. Θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη. - Ενδομητρίωση: Γεννητική και εξωγεννητική ενδομητρίωση (στάδιο I-IV). - Ινομυώματα μήτρας: Θεραπεία των ινομυωμάτων μήτρας. - Πρώιμη ήβη: Προ της ηλικίας των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** - Καρκίνος του προστάτη: Μία ενδομυϊκή ή υποδόρια ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Διάρκεια της θεραπείας: βλέπε παρ. 5.1. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη μη χειρουργικά ευνουχισμένοι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωνιστή GnRH, όπως η triptorelin, και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με abiraterone acetate, έναν αναστολέα της βιοσύνθεσης των ανδρογόνων, ή με enzalutamide, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με GnRH πρέπει να συνεχιστεί. - Ενδομητρίωση: Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Διάρκεια της θεραπείας ενδομητρίωσης: αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδομητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην κλινική εικόνα (λειτουργικές και ανατομικές) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γενικά, συνιστάται η ενδομητρίωση να θεραπεύεται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε μπορεί να συνεχισθεί το ανώτερο μέχρι 6 μήνες. Δεν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά θεραπείας με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ή άλλο ανάλογο γοναδορελίνης. - Ινομυώματα: Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Γενικά, συνιστάται τα ινομυώματα να θεραπεύονται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε μπορεί να συνεχισθεί το ανώτερο μέχρι 6 μήνες. - Πρώιμη ήβη: Η θεραπεία παιδιών με triptorelin πρέπει να βρίσκεται υπό την ολική επιτήρηση παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με εμπειρία στη θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης. **Δοσολογία:** Μία ενδομυϊκή ένεση triptorelin κάθε 3 μήνες. Για λεπτομερείς οδηγίες στη μέθοδο χορήγησης, βλέπε παράγραφο 6.6 "Οδηγίες χρήσης / χειρισμού". Το Arvekap 11,25 mg δεν πρέπει να ενίεται ενδοαγγειακά. Η υποδόρια χορήγηση δεν έχει μελετηθεί σε γυναίκες και παιδιά. **4.3 Αντενδείξεις:** -Υπερευαισθησία στη GnRH, τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου (βλέπε παράγραφο 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες). -Περίοδος κύησης και γαλουχίας: Πριν την έναρξη της αγωγής πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος. **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χρήση αγωνιστών GnRH μπορεί να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να ελαττώσει την απώλεια οστικής πυκνότητας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός). Πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος πριν τη συνταγογράφηση της triptorelin. Σπάνια, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου γοναδοτρόφου αδενώματος της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν υποφυσιακή αποπληξία η οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική κεφαλαλγία, έμετο, προβλήματα όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η triptorelin. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Ασθενείς με διαγνωσμένη κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ρύθμιση της αντιυπερτασικής θεραπείας μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν τέτοια αγωγή. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αντιπηκτικά, λόγω του πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. **Καρκίνος του προστάτη:** Αρχικά, η triptorelin, όπως και άλλοι αγωνιστές GnRH, προκαλεί μία παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να εξεταστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιρροπιστεί η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου) και προσωρινή αύξηση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH, έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής (χειρουργικός ευνουχισμός). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σπονδυλικές μεταστάσεις και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό η triptorelin δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Επιπλέον, από επιδημιολογικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (πχ δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια θεραπείας με στέρηση ανδρογόνων. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και στην αύξηση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση triptorelin σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. Ενότητα 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάζουν το κατά πόσον τα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων περιλαμβανομένης της δυνατότητας για κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη της θεραπείας με Arvekap 11,25mg. **Γυναίκες:** Η χρήση GnRH αγωνιστών είναι πιθανό να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 1% ανά μήνα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου θεραπείας έξι μηνών. Κάθε μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 10% συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η οστική απώλεια αποκαθίσταται στην πλειονότητα των γυναικών, μετά από παύση της θεραπείας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία για ασθενείς με ήδη υπάρχουσα οστεοπόρωση ή με παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός π.χ. νευρογενής ανορεξία). Δεδομένου ότι σε αυτούς τους ασθενείς η μείωση της οστικής πυκνότητας είναι πιθανό να είναι περισσότερο επιβλαβής, η θεραπεία με triptorelin θα πρέπει να εξετάζεται σε ατομική βάση και να ξεκινά μόνο εάν τα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν των κινδύνων, μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να αντιρροπείται η απώλεια οστικής πυκνότητας. **Ινομυώματα μήτρας και ενδομητρίωση:** Η triptorelin όταν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δόση προκαλεί συνεχή υπογοναδοτροφική αμηνόρροια. Εάν μετά τον πρώτο μήνα παρατηρηθεί αιμορραγία γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να μετρηθούν τα επίπεδα της οιστραδιόλης στο πλάσμα και αν τα επίπεδα είναι κάτω από 50 pg/mL, πρέπει να εξεταστούν πιθανές οργανικές βλάβες. Μετά την απόσυρση της θεραπείας, η λειτουργία των ωοθηκών επανέρχεται και ωορρηξία γίνεται περίπου 5 μήνες μετά την τελευταία ένεση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία μη ορμονική μέθοδος αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας έως και 3 μήνες μετά την τελευταία ένεση. Καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με triptorelin η έμμηνος ρύση θα πρέπει να σταματά, πρέπει να δίδονται οδηγίες στην ασθενή ώστε να ενημερώνει τον γιατρό της εάν συνεχίζεται η τακτική εμμηνόρροια. Κατά τη διάρκεια θεραπείας των ινομυωμάτων της μήτρας συνιστάται ο τακτικός προσδιορισμός του μεγέθους του ινομυώματος. Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγίας σε ασθενείς με υποβλεννογόνια ινομυώματα μετά από θεραπεία με ανάλογα GnRH. Συνήθως, η αιμορραγία έχει εμφανιστεί 6 - 10 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. **Πρώιμη ήβη:** Η θεραπεία παιδιών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση των κινδύνων και οφελών. Στα κορίτσια, η αρχική διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των οιστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρύση θα ξεκινήσει κατά μέσο όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Εμπειρία από τις κλινικές μελέτες: Γενική ανοχή σε άνδρες:** Εφόσον οι ασθενείς που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι γενικά ηλικιωμένοι και έχουν και άλλες νόσους οι οποίες απαντούν συχνά σε αυτό τον γηρασμένο πληθυσμό, περισσότεροι από το 90% των ασθενών οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνά η συσχέτιση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Όπως έχει παρατηρηθεί και με άλλες θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με triptorelin οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν εξάψεις και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Με την εξαίρεση των ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (<5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις αλλαγές στην τεστοστερόνη. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανά σχετιζόμενες με τη θεραπεία με triptorelin. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι σχετίζονται με το βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (> 1/10), Συχνές (> 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (>1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). **Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος** Μη συχνές: θρομβοκυττάρωση. **Καρδιακές διαταραχές:** Μη συχνές: Αίσθημα παλμών, Μη γνωστής

συχνότητας: Παράταση διαστήματος QT* (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). **Διαταραχές ακουστικές και λαβυρίνθου:** Μη συχνές: Εμβοή, Ίλιγγος. **Οφθαλμικές διαταραχές:** Μη συχνές: Επηρεασμένη όραση, Σπάνιες: Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών, Διαταραχές όρασης. **Γαστρεντερικές διαταραχές:** Ξηροστομία, Ναυτία, Μη συχνές: Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος, Σπάνιες: Διάταση κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός. **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης:** Πολύ συχνές: Εξασθένηση, Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και Πόνος), Οίδημα, Μη συχνές: Λήθαργος, Περιφερικό οίδημα, Πόνος, Ρίγη, Υπνηλία, Σπάνιες: Πόνος στο στήθος, Διαταραχές στάσεως, Γριππώδης συνδρομή, Πυρεξία, Μη γνωστής συχνότητας: Κακουχία. **Διαταραχές ανοσοποιητικού:** Συχνές: Υπερευαισθησία, Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σοκ. **Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:** Σπάνιες: Ρινοφαρυγγίτιδα. **Εξετάσεις:** Συχνές: Βάρος αυξημένο, Μη συχνές: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση αυξημένη, Βάρος μειωμένο, Σπάνιες: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη. **Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης:** Μη συχνές: Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη. **Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού:** Πολύ συχνές: Οσφυαλγία. Συχνές: Μυοσκελετικός πόνος, Πόνος στα άκρα, Μη συχνές: Αρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία, Σπάνιες: Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων, Μυοσκελετική δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα. **Διαταραχές νευρικού συστήματος:** Πολύ συχνές: Παραισθησία κάτω άκρων, Συχνές: Ζάλη, Κεφαλαλγία, Μη συχνές: Παραισθησία, Σπάνιες: Επηρεασμένη μνήμη. **Ψυχικές διαταραχές:** Πολύ συχνές: Σεξουαλική επιθυμία μειωμένη, Συχνές: Κατάθλιψη*, Απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας, Αλλαγές της διάθεσης*, Μη συχνές: Αϋπνία, Ευερεθιστότητα, Σπάνιες: Συγχυτική Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση, Μη γνωστής συχνότητας: Άγχος. **Διαταραχές νεφρών και ουροποιητικού:** Μη συχνές: Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων, Μη γνωστής συχνότητας: Ακράτεια ούρων. **Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών:** Πολύ συχνές: Στυτική δυσλειτουργία (περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης), Συχνές: Πυελικός πόνος, Μη συχνές: Γυναικομαστία, Πόνος στο στήθος, Ατροφία όρχεων, Πόνος στους όρχεις. **Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές:** Μη συχνές: Δύσπνοια, Επίσταξη, Σπάνιες: Ορθόπνοια. **Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού:** Πολύ συχνές: Υπεριδρωσία, Μη συχνές: Ακμή, Αλωπεκία, Ερύθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Σπάνιες: Φυσαλίδα, Πορφύρα, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. **Αγγειακές διαταραχές:** Πολύ συχνές: Εξάψεις, Συχνές: Υπέρταση, Σπάνιες: Υπόταση. *Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. Η triptorelin, μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική ένεση της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης. Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4). Η χρήση GnRH αγωνιστών στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Γενική ανοχή σε γυναίκες (βλέπε παράγραφο 4.4). Ως συνέπεια των μειωμένων επιπέδων οιστρογόνων οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (αναμενόμενες στο 10% των γυναικών ή παραπάνω) ήταν κεφαλαλγία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, διαταραχή ύπνου, μεταβολή διάθεσης, δυσπαρευνία, δυσμηνόρροια, αιμορραγία γεννητικών οργάνων, σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, υπερτροφία ωοθηκών, πυελικό άλγος, κοιλιακό άλγος, αιδιοκολπική ξηρότητα, υπεριδρωσία, εξάψεις και εξασθένιση. Αναφέρθηκαν οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με triptorelin. Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (> 1/10), Συχνές (> 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (>1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). **Καρδιακές διαταραχές:** Μη συχνές: Αίσθημα παλμών. **Διαταραχές ακουστικές και λαβυρίνθου:** Μη συχνές: Ίλιγγος. **Οφθαλμικές διαταραχές:** Μη συχνές: Ξηροφθαλμία, Επηρεασμένη όραση, Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. **Γαστρεντερικές διαταραχές:** Συχνές: Ναυτία, Κοιλιακό άλγος, Κοιλιακή δυσφορία, Μη συχνές: Διάταση κοιλίας, Ξηροστομία, Μετεωρισμός, Στοματική εξέλκωση, Έμετος, Μη γνωστής συχνότητας: Διάρροια. **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης:** Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. **Διαταραχές ανοσοποιητικού:** Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σόκ. **Εξετάσεις:** Συχνές: Αύξηση βάρους, Μείωση βάρους, Μη συχνές: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη. **Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού:** Συχνές: Αρθραλγία, Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα, Μη συχνές: Οσφυαλγία, Μυαλγία, Μη γνωστής συχνότητας: Μυϊκή αδυναμία. **Διαταραχές νευρικού συστήματος:** Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία, Συχνές: Ζάλη, Μη συχνές: Δυσγευσία, Υποαισθησία, Συγκοπή, Επηρεασμένη μνήμη, Διαταραχή προσοχής, Παραισθησία, Τρέμουλο. **Ψυχικές διαταραχές:** Πολύ συχνές: Διαταραχές ύπνου (περιλαμβάνεται αϋπνία), Μεταβολή διάθεσης, Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, Συχνές: Κατάθλιψη*, Νευρικότητα, Μη συχνές: Ευμεταβλητότητα συναισθήματος, Άγχος, Κατάθλιψη**, Αποπροσανατολισμός, Μη γνωστής συχνότητας: Συγχυτική κατάσταση. **Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών:** Πολύ συχνές: Διαταραχή στους μαστούς, Δυσπαρευνία, Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, Υπερτροφία ωοθηκών, Πυελικό άλγος, Αιδοιοκολπική ξηρότητα, Αιμορραγία γεννητικών οργάνων (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία από απόσυρση), Συχνές: Πόνος μαστών, Μη συχνές: Αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή, Κυστεοκοίλη, Διαταραχή εμμήνου ρύσεως (περιλαμβάνονται δυσμηνόρροια, μητρορραγία, και μηνορραγία), Ωοθηκική κύστη, Κολπική έκκριση. **Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές:** Μη συχνές: Δύσπνοια, Επίσταξη. **Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού:** Πολύ συχνές: Ακμή, Υπεριδρωσία, Σμηγματόρροια, Συχνές: Αλλωπεκία, Ξηροδερμία, Δασυτριχισμός, Ευθραυστότητα ονύχων, Κνησμός, Εξάνθημα, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα, Κνίδωση. **Αγγειακές διαταραχές:** Πολύ συχνές: Εξάψεις, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση. **Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης:** Μη συχνές: Μείωση όρεξης, Κατακράτηση υγρών. *Μακρόχρονη χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. **Βραχύχρονη χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. Κατά την έναρξη της θεραπείας, τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης συμπεριλαμβανομένων κοιλιακού άλγους, δυσμηνόρροιας μπορεί πολύ συχνά (≥ 10%) να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της αρχικής παροδικής αύξησης των επιπέδων της οιστραδιόλης στο πλάσμα. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία με δύο εβδομάδες. Κατά το μήνα που ακολουθεί την πρώτη ένεση μπορεί να προκύψει αιμορραγία γεννητικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων μηνορραγίας, μητρορραγίας. Ο συνδυασμός με γοναδοτροφίνες για τη θεραπεία της υπογονιμότητας, μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Μπορεί να παρατηρηθούν υπερτροφία ωοθηκών, πυελικό και/ ή κοιλιακό άλγος. Γενική ανοχή σε παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.4). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (> 1/10), Συχνές (> 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (>1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). **Οφθαλμικές διαταραχές:** Μη συχνές: Επηρεασμένη όραση, Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. **Γαστρεντερικές διαταραχές:** Συχνές: Κοιλιακό άλγος, Μη συχνές: Έμετος, Δυσκοιλιότητα, Ναυτία. **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης:** Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή), Μη συχνές: Κακουχία. **Διαταραχές ανοσοποιητικού:** Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σόκ (έχει παρατηρηθεί σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες). **Εξετάσεις:** Συχνές: Αύξηση βάρους, Μη γνωστής συχνότητας: Προλακτίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη. **Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού:** Μη συχνές: Πόνος στον αυχένα, Μη γνωστής συχνότητας: Μυαλγία. **Διαταραχές νευρικού συστήματος:** Συχνές: Κεφαλαλγία. **Ψυχικές διαταραχές:** Μη συχνές: Μεταβολή διάθεσης, Μη γνωστής συχνότητας: Ευμεταβλητότητα συναισθήματος, Κατάθλιψη, Νευρικότητα. **Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών:** Πολύ συχνές: Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται Κολπική αιμορραγία, Αιμορραγία από απόσυρση, Αιμορραγία μήτρας, Κολπική έκκριση, Κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας), Μη συχνές: Πόνος μαστών. **Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές:** Μη συχνές: Επίσταξη. **Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού:** Συχνές: Ακμή, Μη συχνές: Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. **Αγγειακές διαταραχές:** Συχνές: Εξάψεις, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση. **Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης:** Μη συχνές: Παχυσαρκία. Έχουν αναφερθεί αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λεμφοκύττωση σχετίζεται προφανώς με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ:+30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 1475 Λευκωσία. Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος:** Φύλαξη σε θερμοκρασία έως 25° C. Μετά την ανασύσταση να χρησιμοποιείται αμέσως. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** IPSEN MON. ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 174 56, Αθήνα, Τηλ.: 210 9843324. Εκπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, Τ.Κ.24018, 1700 Λευκωσία. Τηλ: 00357 22741741. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ελλάδα: 63652 – 28/07/2017. Κύπρος: 19629. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 13/06/2000 - 04/09/2008. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 28/07/2017.

4 ARV 11,25/3,75-A IOVN 2020

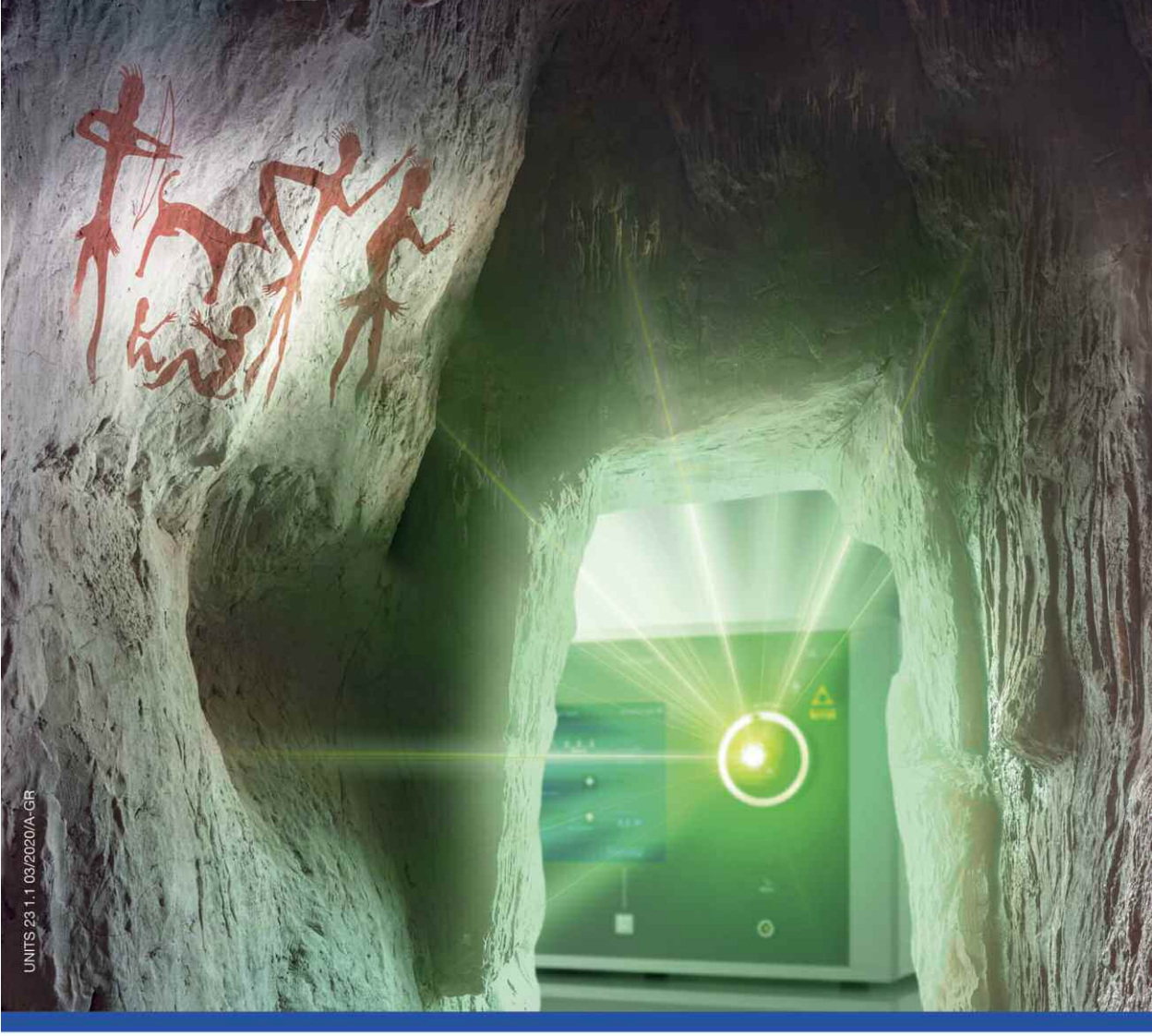
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τ.Π.: 153.62€
Λ.Τ.: 194.73 €
Δ.Τ.Φ.: 13/12/2019

IPSEN
Innovation for patient care

IPSEN MON. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930



UNITS 23.1.1 03/2020/A-GR

Το Τέλος της Λίθινης Εποχής- CALCULASE® III

Σύστημα Holmium laser για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λίθων & ιστών.

- Αποτελεσματικός κατακερματισμός λίθων
- Έτοιμα προγράμματα λειτουργίας
- Εύκολος χειρισμός μέσω οθόνης αφής
- Αυτόματη αναγνώριση ινών

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

75 Years

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
KARL STORZ Endoskope Greece Ltd., Patriarhou Grigoriou E' 34, 54248 Thessaloniki/Greece
www.karlstorz.com

ABISS
Analytic BioSurgical Solutions

inside
MEDICAL

Excellence in surgery

CYRENE

ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

MADE IN FRANCE

Η πρώτη ταινία TOT στον κόσμο
250.000 τοποθετήσεις παγκοσμίως



Αποκλειστική Διάθεση

Inside Ιατρικές Τεχνολογίες

Κρανιάς 1 - 153 44 Γέρακας
Τ: 211 1820 844
info@insidemedical.gr



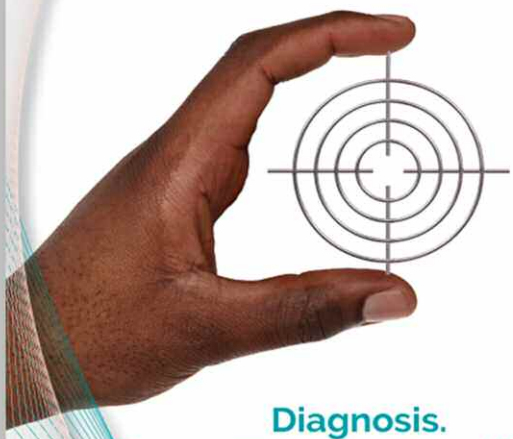
RECORDATI HELLAS
GROUP

Ζωοδόχου Πηγής 7_152 31 Χαλάνδρι_τ 210 6773822_f 210 6773874

CONVEY

BiopSee

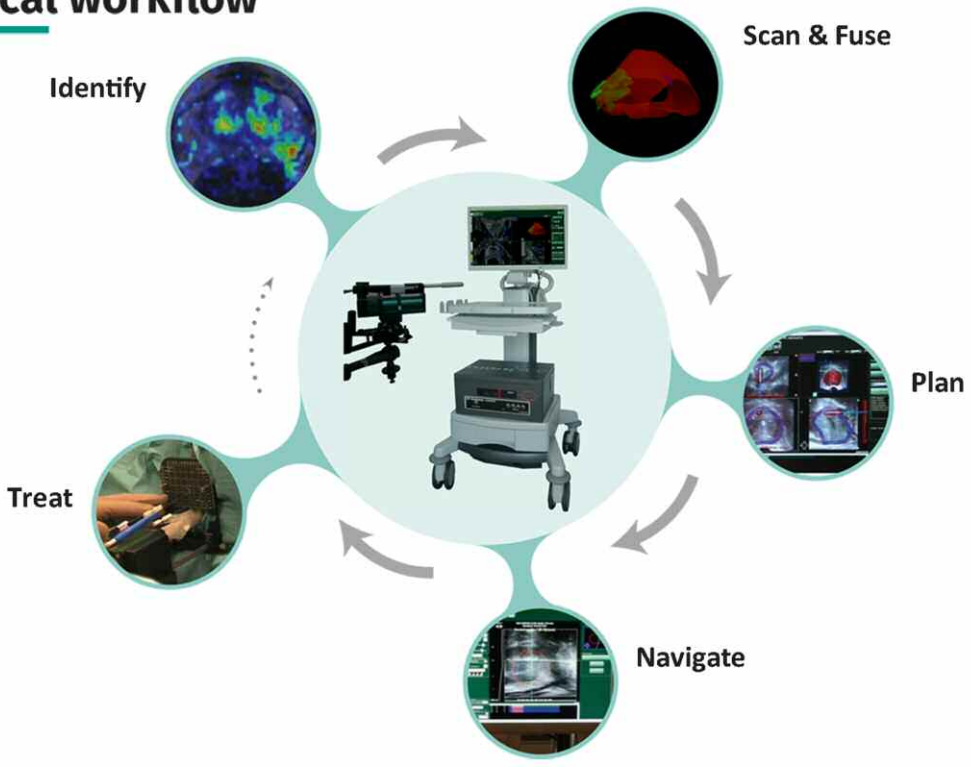
THE COMPLETE PROSTATE SOLUTION



MR/US FUSION NAVIGATION

Diagnosis.
Biopsy. Therapy. Surveillance.
Clinical Studies.

Clinical workflow



SOFMEDICA
LIFE SAVING INNOVATION
SOFMEDICA A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 131, 15124 Μαρούσι, Τηλ: 210-6149470
e-mail: info.gr@sofmedica.com, www.sofmedica.com

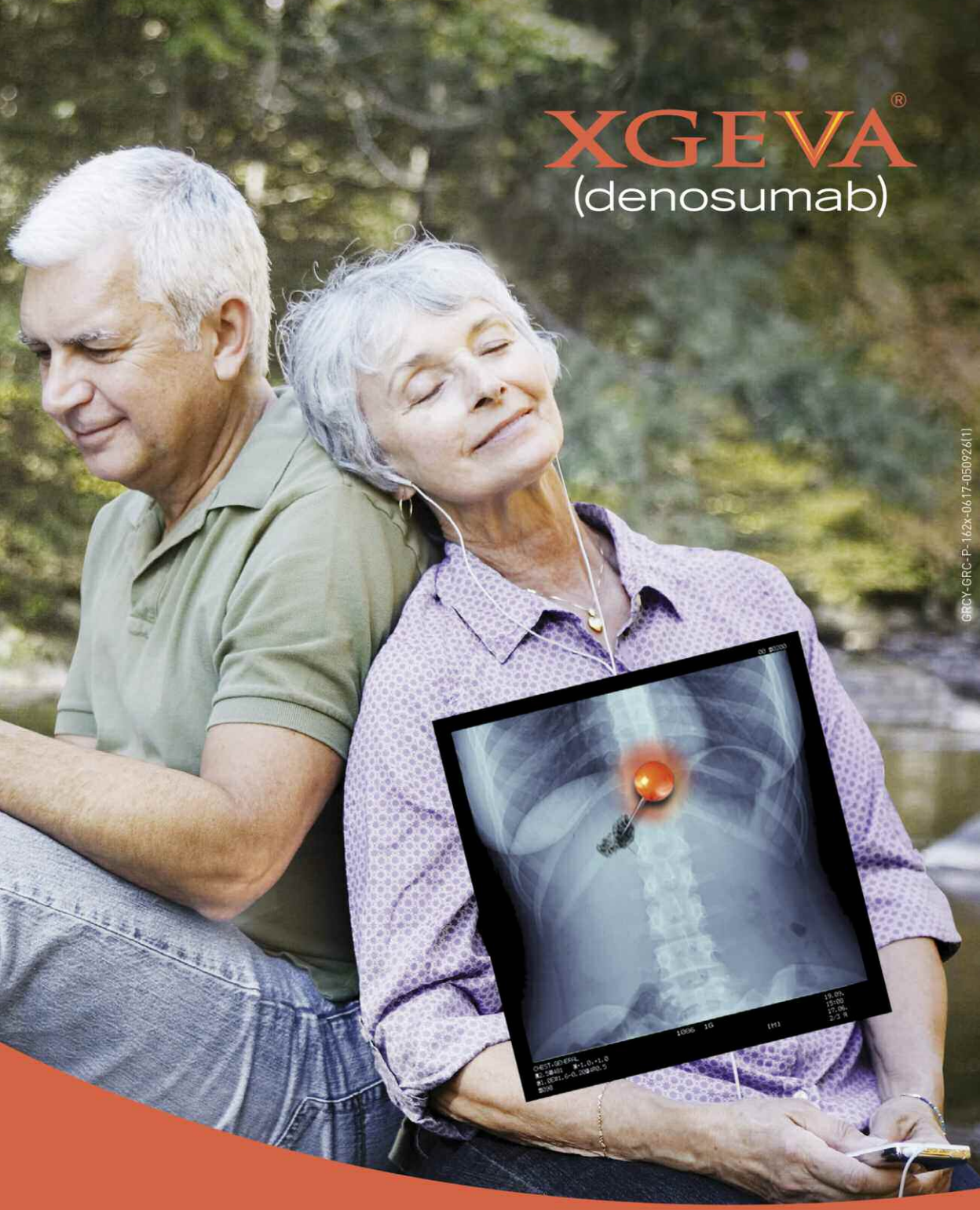
Be spot-on with BiopSee
MEDCOM

BICALUT®

Solicare

genepharm

part of MS pharma



GRCY-GRC-P-162x-0617-050926[1]

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

AMGEN
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr